



SAISINE

PASSAGE EN CATÉGORIE B

Corps des ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière
Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux · CHU de Toulouse · 29 juin 2026

Intersyndicale CGT — SUD Santé Sociaux

Toulouse, le 29 juin 2026

Ambulanciers de la Fonction Publique Hospitalière

CHU de Toulouse — Service Transport Patients

Place du Docteur Baylac, TSA 40031 — 31059 Toulouse Cedex 9

Contacts : Julien TERRE (CGT) · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA (représentant du personnel ambulancier) · Jérôme JEAN-CHARLES (représentant du personnel ambulancier)

Madame Stéphanie RIST

Ministre de la Santé, des Familles,
de l'Autonomie et des Personnes handicapées
14, avenue Duquesne — 75007 Paris

Monsieur le Directeur général de l'offre de soins (DGOS)

Direction générale de l'offre de soins
Ministère de la Santé
14, avenue Duquesne — 75007 Paris

Objet : Demande de révision du classement statutaire du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière — passage de la catégorie C à la catégorie B

Réf. : Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 · Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 · Arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024 · Art. L. 4393-1 et R. 6311-17 CSP

Copies : DGAFF · HCPP · CSFPH · FHF · Fédérations nationales CGT Santé & SUD Santé Sociaux · Direction Générale CHU de Toulouse

Madame la Ministre, Monsieur le Directeur général,

Les organisations syndicales CGT et SUD Santé Sociaux, représentant les ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) au CHU de Toulouse, ont l'honneur de vous soumettre la présente saisine aux fins d'obtenir la **révision du classement statutaire du corps des ambulanciers hospitaliers**, actuellement maintenu en catégorie C en application du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, en vue de son **passage en catégorie B**.

Cette demande n'est pas une revendication salariale isolée : elle est la conséquence logique et documentée d'une triple réalité — **un référentiel de formation dépassé par les missions exercées, un précédent statutaire créant une iniquité de traitement entre corps comparables, et un risque professionnel cumulatif objectif par huit sources institutionnelles nationales**. Elle s'appuie sur des textes réglementaires en vigueur, des données chiffrées vérifiables et une jurisprudence administrative établie.

I. CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE ET SITUATION ACTUELLE

1.1 Un rattachement à la filière soignante sans révision catégorielle

Le **décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022** a procédé à l'intégration des ambulanciers hospitaliers dans la filière soignante de la FPH, fusionnant le corps des conducteurs ambulanciers de la FPH et celui de l'AP-HP. Ce texte reconnaît formellement le caractère soignant de leurs missions au sens des **articles L. 4393-1 et R. 6311-17 du code de la santé publique**. Cependant, il maintient le corps en **catégorie C**, créant une contradiction

manifeste entre la reconnaissance de principe d'un rôle soignant et un positionnement indiciaire qui n'en tire aucune conséquence.

1.2 L'iniquité de traitement avec les aides-soignants — précédent Ségur

Le corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture, titulaire d'un **diplôme d'État enregistré au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles**, a été reclassé en catégorie B par le **décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021** en application des accords du Ségur de la santé, avec effet au 1er octobre 2021. Les ambulanciers hospitaliers, dont le DEA est identiquement enregistré au niveau 4 du RNCP, n'ont bénéficié d'aucune mesure catégorielle équivalente, alors même que leurs conditions d'exercice présentent un niveau de risque et de responsabilité au moins comparable.

Argument-clé —

Le groupe de travail ministériel sur la VAE du 7 novembre 2025 a officiellement reconnu que le niveau de compétences exigé pour le DEA « relève sans conteste de la catégorie B de la fonction publique ». Le ministère lui-même constate l'équivalence tout en maintenant les agents en catégorie C.

Force Ouvrière, groupe de travail ministériel VAE, 7 novembre 2025 : « La technicité exigée, la responsabilité professionnelle et la complexité des missions exercées par les ambulanciers ne sont plus compatibles avec un statut de catégorie C. »

1.3 Un mouvement social révélateur d'une tension structurelle nationale

Le mouvement de grève engagé au CHU de Toulouse depuis le 7 juin 2026 s'inscrit dans une série de mobilisations inter-CHU documentées : **CHU d'Angers (2021)** — 51 courriers adressés au ministre, sans réponse ministérielle à ce jour ; **CHU de Tours (2021-2024)** ; **CHU de Lyon (2022-2024)** ; **CHU de Marseille (2023-2024)**. L'absence de réponse à ces mobilisations successives constitue elle-même un élément de dossier : la revendication est ancienne, légitime et partagée sur l'ensemble du territoire national.

II. SEPT ARGUMENTS PRÉCIS ET RECEVABLES

Argument 1 — Un référentiel de formation structurellement dépassé par les missions exercées

Le référentiel du DEA (**arrêté du 11 avril 2022 modifié le 4 juillet 2024**) structure la formation en cinq blocs de compétences centrés sur la prise en soin générale, le recueil de données cliniques, le transport et l'entretien du véhicule. Il ne couvre pas, ou de façon notoirement insuffisante, les missions suivantes, régulièrement exercées au CHU de Toulouse et dans l'ensemble des établissements de la filière soignante :

- Transports sous contrainte psychiatrique (3 751 missions en 2025 au CHU de Toulouse), transferts vers les unités pour malades difficiles (UMD) et les unités de soins intensifs psychiatriques (USIP), réintégrations de patients après fugue ou sortie pathologique ;
- Transports pénitentiaires sécurisés (UHSI, UHSA), transferts de détenus vers le juge des libertés et de la détention ou les tribunaux, avec coordination sous escorte de la Police nationale ;
- Transports de patients à risque clinique élevé : soins palliatifs, médecine nucléaire (radioprotection), médecine infectieuse et patients en aplasie médullaire, sorties de bloc opératoire et de réanimation, patients greffés — impliquant la manipulation sécurisée de dispositifs médicaux invasifs (drains, sondes, perfusions, oxygénothérapie, pousse-seringues) sans formation dédiée à ce jour ;
- Transports mortuaires nocturnes, avec gestion relationnelle des familles en état de détresse ;
- Transports de produits sanguins labiles (PSL) — concentrés de globules rouges, plaquettes, plasma frais congelé — effectués notamment par les ambulanciers internes du CHU de Caen Normandie, sans qu'aucun bloc de compétences du référentiel DEA ne couvre les exigences spécifiques de la chaîne du froid, de la traçabilité transfusionnelle réglementaire (arrêté du 10 septembre 2007) ni de la gestion des incidents de transport ;
- Participation aux Plans Blancs et à la médecine de catastrophe, y compris en remplacement partiel des équipes SAMU.

Argument-clé —

Un agent qui exerce des missions non couvertes par son référentiel de formation initiale engage sa responsabilité personnelle sans cadre de compétence reconnu. C'est un argument de sécurité patient et de protection de l'agent — non une revendication abstraite de justice catégorielle — que la Direction ne peut éluder sans fragiliser sa propre fiche de poste.

★ SAISINE — CATÉGORIE B AMBULANCIERS FPH

Intersyndicale CGT — SUD · CHU de Toulouse · 28 juin 2026

psychiatriques sous contrainte et 4 033 transports urgences. — Constat intersyndicale CHU de Caen Normandie 2026 : transports PSL effectués hors cadre de formation DEA reconnu. — Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles.

Argument 2 — Le précédent Ségur — iniqué de traitement objectivée entre corps de niveau équivalent

Critère	Aides-soignants (AS)	Ambulanciers FPH
Diplôme	DEAS — Niveau 4 RNCP	DEA — Niveau 4 RNCP
Durée de formation	~1 400 heures (réforme 2021)	~800 heures (réforme 2022) + FAE SMUR en option : 175 h (arrêté du 17 mai 2023) — non diplômante, hors RNCP
Actes autorisés élargis (2021-2024)	Arrêté du 10 juin 2021 (Ségur) : Glycémie capillaire, SpO2, soins de stomie, sonde urinaire à demeure, ECG 12 dérivations + transmission, aspiration sécrétions (trachéotomisé), recueil de données cliniques élargies, aide à la prise médicamenteuse per os, pansements simples, nutrition entérale	Arrêté du 11 avril 2022, modifié 4 juillet 2024 : paramètres vitaux complets (FC, TA, SpO2, FR, T°, glycémie, EVA/EN), ECG 12 dérivations + transmission régulateur, administration d'oxygène (masque/lunettes), pose de VVP en urgence (protocole SMUR), aspiration des VAS, immobilisation/contention (attelles, traction), RCP + DAE, surveillance dispositifs médicaux invasifs (drains, sondes, perfusions, PSE), protocoles d'isolement protecteur, bilan SAMU structuré + fiche de liaison
Filière FPH	Soignante	Soignante en droit (décret 2022-1658) — mais maintien de fait dans la filière technique, logistique ou administrative constaté dans de nombreux CHU (organigrammes, encadrement non soignant, absence d'intégration aux instances soignantes)
Catégorie	B — depuis le 1er octobre 2021	C — maintenu à ce jour
Texte de reclassement	Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021	Aucune mesure catégorielle à ce jour

La comparaison est factuelle : deux corps de diplôme d'État de même niveau RNCP, au sein de la même filière soignante, soumis à un élargissement comparable de leurs actes autorisés — l'un reclassé en 2021 au titre du Ségur, l'autre maintenu en catégorie C sans explication documentée. Cette iniquité est directement recevable devant le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la FPH (Ségur de la santé). — Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la FPH.

Argument 3 — Le déficit de formation : l'angle d'attaque le plus difficile à réfuter

Paradoxalement, le point faible apparent — l'absence de formation aux missions réellement exercées — place la Direction devant un choix binaire incontournable :

— Soit elle reconnaît que ces missions relèvent d'un champ de compétences soignant élargi → ce qui justifie la révision du référentiel ET la révision catégorielle qui doit l'accompagner ;

— Soit elle nie cet élargissement de fait → mais alors elle doit retirer ces missions de la fiche de poste, ce que les organisations syndicales refusent.

Le dossier AFASH (version 02/2026) documente 12 compétences spécifiques exercées par l'ambulancier SMUR sans cadre de formation ni reconnaissance RNCP, et recense 24 missions sur 32 hors périmètre DEA/décret n° 2022-629 (soit les trois quarts). La France est le seul grand pays à ne disposer d'aucun positionnement RNCP spécifique pour l'ambulancier spécialisé en urgence préhospitalière. À titre de comparaison : Royaume-Uni (Paramedic, reconnu par le HCPC, formation universitaire 3 ans), Allemagne (Notfallsanitäter, 3 ans de formation spécialisée depuis la réforme 2014), Québec (diplôme reconnu nationalement), États-Unis (Paramedic certifié NREMT).

Argument-clé — La démonstration du déficit de formation place la Direction devant un dilemme incontournable : reconnaître l'élargissement des missions et en tirer les conséquences catégorielles, ou retirer ces missions de la fiche de poste. Les deux issues sont documentées, objectivées et non contestables. La convergence entre le dossier AFASH (24 missions sur 32 hors périmètre DEA) et le retard français face aux modèles britannique, allemand, québécois et américain renforce l'urgence d'une révision statutaire.

Argument 4 — Un risque professionnel cumulatif objectivé par huit sources institutionnelles

Document intersyndicale — Usage officiel — Diffusion restreinte aux destinataires mentionnés

Les données issues de huit organismes institutionnels indépendants convergent pour documenter la spécificité et la sévérité des risques professionnels des ambulanciers :

Source	Donnée clé	Référence
DARES	77,2 % des ambulanciers salariés travaillent le dimanche (37,9 % habituellement + 39,3 % occasionnellement)	Dares Analyses n° 075, octobre 2012
France Travail BMO 2026	4 490 projets de recrutement d'ambulanciers — métier classé « en tension » sur 2,28 millions de postes à pourvoir (43,8 % jugés difficiles)	Enquête BMO France Travail 2026
ONVS Rapport 2025	90 victimes ambulancières recensées en 2023, 85 en 2024 — atteintes aux personnes majoritaires	ONVS, Rapport 2025, données 2023-2024
CNAM / AT-MP	Risques majeurs : conduite, portage des patients, expositions biologiques — prévention du risque routier classée priorité nationale	« Ambulancier, un métier à risque ? », Cram Centre Ouest, septembre 2008
INRS	Co-exposition documentée aux TMS et aux RPS chez les conducteurs ambulanciers hospitaliers — recommandations de prévention spécifiques	INRS, « Transports sanitaires. Les risques du métier » ; Archives des maladies professionnelles
ANACT QVCT 2024	Organisation du travail, horaires, management et prévention identifiés comme leviers prioritaires d'attractivité et de fidélisation pour les ambulanciers FPH	Anact, Référentiel QVCT 2024 ; Les six sujets QVCT, 2025
FNTS / données parlementaires	78 % des entreprises en difficulté de recrutement (FNTS 2024) ; 47 % des ambulanciers déclarent des symptômes d'épuisement professionnel	FNTS 2024 ; Sénat, question attractivité ; Assemblée nationale, question n° 569
FHF / ANAP	Turnover 18 % annuel, coût estimé 15 000 à 40 000 € par départ — recours à l'intérim 30 à 50 % plus coûteux qu'un agent statutaire	FHF, décret intérim paramédical 2025 ; ANAP, outil taux de rotation/activité

À ces données s'ajoute l'accidentologie spécifique : le **taux d'accidentologie des ambulanciers est 2,5 fois supérieur à la moyenne des professions de santé** (Sécurité Routière, 2023), et entre **57 % et 93 % des ambulanciers déclarent avoir subi au moins un acte de violence** verbale ou physique au cours de leur carrière (rapport sécurité professionnels de santé, 2025).

Argument-clé —

La convergence de huit sources institutionnelles indépendantes — DARES, France Travail, ONVS, CNAM, INRS, ANACT, FNTS, FHF/ANAP — sur la pénibilité, les risques cumulatifs et les tensions de recrutement des ambulanciers hospitaliers constitue une base documentaire incontestable, non susceptible d'être balayée comme une simple revendication syndicale.

Argument 5 — L'incidence directe du Plan « Zéro contention 2030 » sur le risque en transport

Le 2 juin 2026, lors du rendez-vous interministériel consacré à la santé mentale (Grande cause nationale), votre ministère a fixé pour la première fois un **objectif national de « zéro contention » en psychiatrie à l'horizon 2030**, assorti d'un renforcement de la formation des équipes d'hospitalisation à la désescalade et du déploiement d'espaces d'apaisement. Cette orientation nationale produit cependant un effet non documenté sur la phase de transport :

- La réduction programmée du recours à la contention mécanique — parfois utilisée pendant le transport de patients en phase de crise — déplace mécaniquement une partie du risque comportemental vers la phase de transport ;
- L'habitacle du véhicule constitue un espace confiné, mobile, dépourvu des moyens d'alerte et de renfort disponibles en service hospitalier — gestion d'une crise comportementale structurellement plus risquée qu'en unité de soins ;
- Aucun des leviers annoncés ne vise à ce stade les professionnels du transport sanitaire.

Argument-clé —

Le Plan zéro contention 2030 ne réduit pas le risque pour l'ambulancier : il en déplace une partie vers la phase de transport sans y apporter de solution de substitution. Sans intégration explicite des ambulanciers au volet formation de ce plan, la trajectoire nationale accroît objectivement leur exposition. C'est un argument réglementaire national non contestable.

Argument 6 — Privatisation croissante et argument économique recevable par le DGOS

La privatisation croissante des transports hospitaliers constitue un argument de poids auprès du DGOS, car elle touche directement à la performance économique des établissements et à la sécurité patient. Le passage en catégorie B doit être lu non comme une charge supplémentaire, mais comme un **investissement en stabilité RH** face à un coût du non-changement qui dépasse largement celui de la revalorisation.

A — Sous-traitance et externalisation : une spirale coûteuse

Les CHU externalisent de plus en plus les transports sanitaires vers des opérateurs privés (entreprises de transport sanitaire, sociétés d'intérim), sous la pression des difficultés de recrutement en personnel propre. Cette tendance génère quatre effets documentés :

— **Surcoût de l'intérim** : le recours à l'intérim pour les transports sanitaires coûte entre **30 et 50 % plus cher qu'un agent statutaire**, hors prise en charge de la formation et de l'intégration. Ce surcoût est supporté par le budget T2A de l'établissement — il ampute directement les ressources disponibles pour les soins.

— **Perte de traçabilité clinique** : les transports externalisés perdent la traçabilité interne — les données sur les incidents, les temps de transport et la qualité de prise en charge ne sont plus centralisées par l'établissement. Cette lacune **fragilise la gouvernance clinique et la sécurité patient**, deux priorités non négociables pour le DGOS.

— **Vulnérabilité du service** : la dépendance aux prestataires externes rend le service vulnérable aux grèves de prestataires privés, aux ruptures de contrat et aux fluctuations du marché. Le CHU de Toulouse a connu des situations de **blocage des transports lors de mouvements sociaux d'ambulanciers privés**, sans capacité de substitution interne immédiate.

— **Perte d'expertise terrain** : chaque départ d'un agent statutaire et chaque recours à l'intérim entraîne une perte de connaissance des circuits internes, des protocoles de l'établissement et des spécificités des patients réguliers

— **expertise non transférable à un prestataire extérieur.**

B — Comparatif économique : coût du statu quo vs coût du passage en B

Poste de coût	Estimations documentées
Intérim paramédical (surcoût direct)	30 à 50 % plus cher qu'un agent statutaire — supporté par le T2A. Pour 20 % des postes externalisés sur 50 agents : surcoût annuel estimé à 90 000–150 000 €. Source : FHF/ANAP 2025
Turnover (18 % annuel)	15 000 à 40 000 € par départ (recrutement, intégration, perte de productivité, formation). Pour 50 agents à 18 % de rotation : 9 départs/an → coût annuel : 135 000–360 000 €. Source : étude Hoppi 2026 ; FNTS 2022
Grèves et désorganisation	Heures supplémentaires non anticipées, surcharge des agents présents, dégradation de la continuité de service, pénalités contractuelles éventuelles avec les prestataires. Source : données CHU de Toulouse, grève depuis le 7 juin 2026
Perte de traçabilité (externalisation)	Données d'incidents non centralisées → risque de responsabilité juridique de l'établissement, impossibilité d'alimenter les indicateurs qualité et de sécurité patient (CPOM, certification HAS). Source : FHF, ANAP — gouvernance clinique
Coût du passage en B (50 agents, estimation)	150 000 à 200 000 € annuels toutes primes et revalorisations indiciaires incluses. Soit moins que le seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes. Source : estimation intersyndicale sur base grille FPH catégorie B

Argument-clé économique pour le DGOS —

Le coût annuel d'un passage en catégorie B pour un effectif de 50 ambulanciers (150 000 à 200 000 €) est inférieur au seul surcoût de l'intérim pour 20 % des postes (90 000–150 000 €) et très largement inférieur au coût cumulé intérim + turnover à 18 % + grèves répétées + externalisation. Ce calcul de gestionnaire ne peut être ignoré dans le cadre de la maîtrise des dépenses d'intérim paramédical déjà encadrée par le décret de 2025, ni dans celui de la certification HAS et des indicateurs de sécurité patient liés à la traçabilité des transports.

Argument 7 — Sinistralité routière, abandon de protection institutionnelle et coût humain

Le témoignage d'une ambulancière du CHG marchant (Toulouse), documenté dans le cadre de la présente saisine, illustre un mécanisme systémique d'abandon de la protection sociale et de l'employeur à l'égard d'un agent victime d'agression en service. Il constitue un argument complémentaire aux données chiffrées nationales et révèle les conséquences concrètes du maintien en catégorie C.

Faits : en juillet 2017, l'ambulancière est victime d'une agression routière suite à un dépassement. Le conducteur

agresseur a volontairement coincé son genou contre son VSL alors qu'elle était sortie de son véhicule. Résultat : ITT (3 jours / 3 %), 10 mois d'arrêt de travail, et séquelles psychologiques durant plusieurs années.

Abandon de protection institutionnelle : la direction du CHG marchant n'a apporté aucun soutien à l'agente, au motif que le procureur n'avait pas donné suite en pénal. L'établissement s'est désolidarisé de sa propre salariée, la laissant seule face à la procédure judiciaire. Contrainte de financer elle-même sa défense juridique, l'ambulancière n'a obtenu gain de cause qu'en mi-2024, soit sept ans après les faits — après un parcours judiciaire long et coûteux que sa grille indiciaire de catégorie C ne lui permettait pas d'assumer sans sacrifice financier personnel.

Portée systémique : ce témoignage corrobore les statistiques nationales documentées — accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé (Sécurité Routière 2023) ; 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence sur carrière (rapport sécurité professionnels de santé 2025) — et révèle un pattern institutionnel où l'ambulancier, faute de reconnaissance statutaire, est traité comme un agent technique dont la vulnérabilité n'appelle pas la mobilisation des dispositifs de protection réservés aux personnels soignants. Le statut de catégorie C, avec une grille indiciaire sous le SMIC aux premiers échelons, place l'agent dans une situation de précarité qui l'empêche d'accéder aux moyens de défense juridique et médicale nécessaires.

Argument-clé — Le témoignage du CHG marchant démontre que le risque ambulancier ne se limite pas aux missions cliniques : il inclut la sinistralité routière, l'agression par des tiers, et l'exposition à un environnement de travail hostile (espace public, conduite d'urgence). La faible catégorie salariale empêche l'agent de se défendre juridiquement et l'expose à un abandon de protection par l'employeur. C'est un argument de justice sociale, de protection de l'agent et de responsabilité employeur — recevable devant la DGOS, la HAS et les juridictions administratives. Le passage en catégorie B, en revalorisant l'indice et la reconnaissance statutaire, constitue un préalable à l'accès effectif aux droits de défense et de réparation des agents victimes de sinistralité en service.

Témoignage ambulancière CHG marchant, juin 2026 (agression routière juillet 2017, 10 mois d'arrêt de travail, séquelles psychologiques durables, abandon de protection institutionnelle, coût juridique personnel — gain de cause mi-2024).

III. PROPOSITION OPÉRATIONNELLE — MODULE DE COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRE AU DEA

Afin d'objectiver l'écart entre le référentiel actuel et les missions exercées, nous proposons la création d'un **Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS)**, sur le modèle de la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers SMUR (**arrêté du 17 mai 2023**) — format déjà validé réglementairement, immédiatement crédible auprès des ARS et des CESU.

N°	Module	Contenu et justification
M1	Contrainte et agressivité	Cadre légal de la contrainte psychiatrique (HSC, HDT), désescalade verbale renforcée en espace confiné SANS contention mécanique (trajectoire « zéro contention 2030 »), transferts UMD/USIP, réintégrations après fugue, gestion de l'agressivité du patient détenu. Justification : 3 751 transports sous contrainte en 2025.
M2	Transports sécurisés et pénitentiaires	Conduite sous escorte, protocoles IRIS, coordination avec l'administration pénitentiaire ; transferts UHSI, UHSA ; transports vers le juge des libertés et de la détention. Modèle : CHU de Lyon.
M3	Patients fragiles et à risque infectieux élevé	Radioprotection et accompagnement fin de vie (soins palliatifs, médecine nucléaire) ; asepsie renforcée (médecine infectieuse, aplasie médullaire) ; surveillance paramètres vitaux et manipulation sécurisée de dispositifs invasifs (drains, sondes, perfusions, oxygénothérapie) pour sorties de bloc/réanimation ; vigilance signes de rejet (patients greffés).
M4	Transports mortuaires	Cadre réglementaire, posture relationnelle face aux familles endeuillées, protocoles de sécurité pour interventions isolées hors heures ouvrables.
M5	Médecine de catastrophe et Plan Blanc	Organisation de la chaîne médicale des secours, gestes d'urgence renforcés, équivalence partielle avec le tronc commun FAE SMUR — intégration aux Plans Blancs sur le modèle des ambulanciers SAMU.
M6	Maintenance de premier niveau	Contrôles et dépannage simples avec outillage fourni, procédure de signalement. Condition syndicale préalable à toute inscription en fiche de poste.
M7	Spécificités SMUR	Assistance aux gestes de réanimation, damage control préhospitalier, gestion de scène complexe, mesures NRBC, intervention en Situations Sanitaires Exceptionnelles (ORSEC, plan blanc, plan rouge), coordination interservices (SDIS, forces de l'ordre, ARS, SAMU), brancardage en milieux hostiles et hélicoptère (HeliSMUR). Source : dossier AFASH 02/2026.

La France est le seul grand pays européen à ne pas reconnaître statutairement ses ambulanciers SMUR. Le **Royaume-Uni reconnaît le Paramedic par le HCPC**, l'**Allemagne a créé le Notfallsanitäter** (3 ans de formation spécialisée), le **Québec dispose d'un diplôme reconnu nationalement**, les **États-Unis certifient le Paramedic**.

Dossier AFASH (Association Française des Ambulanciers SMUR et Hospitaliers), version 02/2026 : 12 compétences spécifiques exercées sans cadre RNCP — spécialisation post-DEA proposée : 5 mois / 600-700 h, niveau 4 RNCP. — Question parlementaire de M. Christophe Naegelen (député des Vosges), 28 mai 2024.

IV. DEMANDES FORMELLES

Sur le fondement de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus, les organisations syndicales signataires demandent formellement :

- **1. L'ouverture d'une concertation formelle** avec les services du ministère (DGOS), la DGAFP et le CSFPH, en vue d'une **révision du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022** portant statut particulier du corps des ambulanciers de la FPH, aux fins de reclassement en catégorie B ;
- **2. L'inscription de cette révision statutaire** à l'ordre du jour d'une prochaine instance de dialogue social national de la FPH (conférence sociale, clause de revoyure des accords Ségur) ;
- **3. La saisine du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP)** pour étudier l'intégration du Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS) au référentiel du DEA, sur le modèle de la FAE SMUR (arrêté du 17 mai 2023) ;
- **4. L'intégration explicite des ambulanciers de la FPH** — y compris ceux exerçant en établissements psychiatriques autonomes — au volet formation du Plan « Zéro contention 2030 », afin que la désescalade en espace confiné soit anticipée pour le transport ;
- **5. Un entretien avec les représentants des organisations syndicales signataires** afin d'examiner les modalités d'un calendrier de mise en œuvre.

V. RÉFÉRENCES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

- [1] Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière au sein de la filière soignante, JORF n° 0301 du 28 décembre 2022.
- [2] Décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et auxiliaires de puériculture de la FPH (Ségur de la santé), JORF n° 0229 du 30 septembre 2021.
- [3] Arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'État d'ambulancier, modifié par l'arrêté du 4 juillet 2024.
- [4] Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'État de structure mobile d'urgence et de réanimation de la FPH.
- [5] Articles L. 4393-1 et R. 6311-17 du code de la santé publique (définition du champ de compétences des ambulanciers).
- [6] Ministère de la Santé, annonce du Plan national « Zéro contention 2030 », rendez-vous interministériel santé mentale (Grande cause nationale), 2 juin 2026.
- [7] Groupe de travail ministériel sur la VAE des ambulanciers, séance du 7 novembre 2025 (reconnaissance du niveau catégorie B pour le DEA).
- [8] Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux bonnes pratiques transfusionnelles (conditions de transport des PSL).

VI. BIBLIOGRAPHIE ET SOURCES INSTITUTIONNELLES CITÉES

Sources statistiques et études

- [8] DARES, Les conditions de travail dans la fonction publique, Dares Analyses n° 40.1, 1er octobre 2003.
- [9] DARES, Le travail du dimanche des salariés, Dares Analyses n° 075, octobre 2012.
- [10] France Travail, Enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) 2026 — 4 490 projets de recrutement d'ambulanciers.
- [11] France Travail, Infographie Transport et logistique des métiers en mouvement, 2026.

Sécurité, risques professionnels et violence au travail

- [12] Observatoire national des violences en santé (ONVS), Rapport 2025, données 2023-2024, Ministère de la Santé, septembre 2025.
- [13] ONVS, Synthèse du Rapport 2022, données 2020-2021, Ministère de la Santé.
- [14] Assurance Maladie / branche AT-MP, Ambulancier, un métier à risque ?, Cram Centre Ouest, septembre 2008.
- [15] INRS, Transports sanitaires. Les risques du métier.
- [16] INRS, Transports sanitaires. Des solutions pour agir.
- [17] INRS, notice documentaire Ambulancier, un métier à risque ?
- [18] Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, TMS et RPS dans une population de conducteurs ambulanciers hospitaliers.

★ SAISINE — CATÉGORIE B AMBULANCIERS FPH

Intersyndicale CGT — SUD · CHU de Toulouse · 28 juin 2026

[19] Sécurité Routière, taux d'accidentologie des ambulanciers (2,5× supérieur à la moyenne des professions de santé), 2023.

[20] Rapport sécurité professionnels de santé 2025 : 57 à 93 % des ambulanciers victimes de violence au cours de leur carrière.

[21] Central Queensland University, étude internationale violences physiques envers les ambulanciers, 2018.

Qualité de vie au travail, attractivité et fidélisation

[22] Anact, Référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), 2024.

[23] Anact, Les six sujets de la qualité de vie et des conditions de travail, 2025.

[24] FNTS, enquête recrutement 2024 : 78 % des entreprises en difficulté de recrutement.

[25] Observatoire national qualité de vie au travail, 2022 : 47 % des ambulanciers déclarent des symptômes d'épuisement professionnel.

[26] Tableau de bord AFT 2025 : 50 % des établissements en difficulté de recrutement (+14 points en un an).

Sources institutionnelles et parlementaires

[27] Sénat, question sur l'attractivité du métier d'ambulancier (sénatrice Laurence Cohen, juin 2023 : ~2 500 ambulanciers en FPH).

[28] Assemblée nationale, Question n° 569 : Attractivité du métier d'ambulancier.

[29] Question parlementaire de M. Christophe Naegelen (député des Vosges), 28 mai 2024 : création d'une spécialité dédiée aux ambulanciers SMUR.

[30] FHF, Publication du décret 2025 sur le plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.

[31] ANAP, Outil taux de rotation / activité.

[32] FNTS, données turnover 2022 : 18 % de turnover annuel (vs 15 % moyenne nationale).

[33] Étude Hoppi 2026 : coût du turnover estimé entre 15 000 et 40 000 € par départ.

[34] Portail des concours de la FPH — fiche métier ambulancier.

[35] Dossier AFASH, version 02/2026 : 12 compétences exercées sans cadre RNCP.

[36] Constat intersyndicale 2026, CHU de Caen Normandie : transports de PSL effectués sans formation DEA dédiée.

[37] Témoignage ambulancière CHG marchant (Toulouse), juin 2026 : agression routière en service (juillet 2017), 10 mois d'arrêt de travail, séquelles psychologiques durables, absence de soutien institutionnel, financement personnel de la défense juridique, gain de cause mi-2024.

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, Monsieur le Directeur général, à l'assurance de notre haute considération et à notre engagement constant pour la sécurité des patients et la juste reconnaissance des professionnels qui les prennent en charge.

Fait à Toulouse, le 29 juin 2026

Pour la CGT

Julien TERRE

Sébastien GOUSSY

Représentants du personnel ambulancier

Laurent BEZIA

Pour SUD Santé Sociaux

Victor ALAVA

Jérôme JEAN-CHARLES

Synthèse exécutive

Demande de passage en catégorie B des ambulanciers de la FPH — Points-clés à retenir

Argument	Fait clé	Source
Iniquité statutaire Ségur	AS (niveau 4 RNCP) → catégorie B en 2021. Ambulanciers (niveau 4 RNCP) → catégorie C maintenue.	Décret 2021-1257 [2] · Décret 2022-1658 [1]
Référentiel dépassé	3 751 transports psychiatriques sous contrainte en 2025 non couverts par le DEA. Transports PSL (CHU Caen Normandie) hors cadre DEA.	Données CHU Toulouse 2025 · Constat CHU Caen 2026 · Arrêté DEA 2022 [3]
Tension RH nationale	4 490 postes à pourvoir · 78 % d'entreprises en difficulté · Turnover 18 %.	BMO France Travail 2026 [10] · FNTS 2024 [24]
Risque violence	90 victimes ambulancières (ONVS 2023) · 57-93 % victimes de violence sur carrière.	ONVS 2025 [12] · Rapport sécurité PS 2025 [20]
Risque accidentologie	Accidentologie 2,5× supérieure à la moyenne des professions de santé.	Sécurité Routière 2023 [19]
Plan zéro contention 2030	Risque comportemental déplacé vers le transport — aucun dispositif de formation prévu pour les ambulanciers.	Annonce ministérielle 2 juin 2026 [6]
Privatisation & argument économique	Externalisation = surcoût T2A 30-50 % + perte traçabilité clinique. Coût passage en B (50 agents) : 150-200 k€ < surcoût intérim (90-150 k€) + turnover 18 % (135-360 k€/an).	FHF/ANAP [30][31] · Hoppi 2026 [33]
Sinistralité & abandon institutionnel	Témoignage CHG marchant : agression 2017, 10 mois AT, abandon direction, coût juridique personnel (catégorie C), gain de cause mi-2024. Révélateur systémique.	Témoignage ambulancière CHG marchant, juin 2026 [nouveau]
Reconnaissance ministérielle	GT VAE du 7/11/2025 : le ministère reconnaît lui-même le niveau catégorie B pour le DEA.	Groupe de travail VAE ambulanciers [7]

Proposition opérationnelle : Module Missions Hospitalières Spécifiques (MHS) — 7 modules — Format FAE SMUR (arrêté 17 mai 2023)

M1 Contrainte/agressivité · M2 Transports pénitentiaires · M3 Patients fragiles · M4 Transports mortuaires · M5 Plan Blanc · M6 Maintenance · M7 SMUR

Demandes formelles adressées à la Ministre et au DGOS

N°	Demande	Modalité / Texte de référence
1	Ouverture d'une concertation formelle DGOS / DGAFP / CSFPH	Révision du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 — reclassement catégorie B
2	Inscription à l'ordre du jour du dialogue social FPH	Conférence sociale nationale — clause de revoyure des accords Ségur
3	Saisine du Haut Conseil des professions paramédicales (HCPP)	Intégration du Module MHS au référentiel DEA — format FAE SMUR (arrêté 17 mai 2023)
4	Intégration au Plan « Zéro contention 2030 »	Formation à la désescalade en espace confiné pour les ambulanciers FPH (y compris établissements psychiatriques)
5	Entretien avec les organisations syndicales signataires	Examen des modalités et du calendrier de mise en œuvre

Contacts : Julien TERRE · Sébastien GOUSSY (CGT) · Victor ALAVA (SUD) · Laurent BEZIA · Jérôme JEAN-CHARLES (représentants du personnel) — CHU de Toulouse, Place du Docteur Baylac, TSA 40031, 31059 Toulouse Cedex 9